

LIBRETTO-432

輔助性 Selpercatinib 用於 RET 融合早期 NSCLC

Adjuvant Selpercatinib in Resected RET Fusion–Positive NSCLC

讀書會共筆整理 | 謝慕揚 MD, PhD, FESC · 2026-06-04

原文：[N Engl J Med 2026 \(DOI 10.1056/NEJMoa2602628\)](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2602628)

一句話總結

- 已根治之 **RET 融合陽性早期 NSCLC**，輔助 **selpercatinib** vs 安慰劑
- II/IIIA 期 **2 年 EFS 92% vs 61%** (**HR 0.17**，**95% CI 0.06–0.51**，**P<0.001**)
- 復發/惡化/死亡風險降低約 **83%**

把轉移期有效的標靶藥**前移到術後輔助**，攔截微小殘留病灶。

背景

- **RET 融合**：NSCLC 罕見（~1–2%）但可標靶之驅動突變
- **Selpercatinib**：高選擇性、**CNS 可穿透** RET 抑制劑，已核准用於晚期 RET+ NSCLC
- 早期 NSCLC 術後仍高復發 → 輔助標靶能否降低復發？（過去未知）

研究設計 (PICO)

元素	內容
P	已根治之 RET 融合陽性早期 NSCLC
I	輔助 selpercatinib (最長 3 年)
C	安慰劑
O	研究者評估 EFS (II/IIIA 期)

- 第三期、**雙盲**；次要含 BICR EFS、OS、安全性

主要結果

終點	Selpercatinib	安慰劑	效果
收案	75	76	共 151
中位隨訪	24 月	27 月	
2 年 EFS (II/IIIA, n=109)	92%	61%	HR 0.17 (0.06–0.51), P<0.001

- BICR 與研究者評估一致

2 年無事件比例由 6 成 → 9 成。

安全性與限制

- 長期口服標靶藥；型態與晚期試驗相似（肝酵素↑、**高血壓**、**QT 延長**、水腫）
- **限制**：
 - 樣本小（151）、事件少、**OS 未成熟**
 - 隨訪短、最佳療程長度待定
 - RET 融合罕見 → 篩檢門檻
- **Cardio-oncology**：監測**血壓與 QTc**

Take-home

1. RET 融合可標靶；selpercatinib 為 CNS 可穿透選擇性 RET 抑制劑。
2. LIBRETTO-432：輔助 selpercatinib，II/IIIA 期 **2 年 EFS 92% vs 61% (HR 0.17)**。
3. 標靶藥前移輔助大幅降復發；OS 未成熟、樣本小。
4. 監測高血壓與 QTc。

參考文獻

1. Wu YL, Goldman JW, Dilon A, et al. Adjuvant Selpercatinib in RET Fusion–Positive NSCLC (**LIBRETTO-432**). *N Engl J Med*. 2026 May 31. DOI [10.1056/NEJMoa2602628](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2602628)
2. Dilon A, et al. Selpercatinib in RET Fusion–Positive NSCLC (**LIBRETTO-001**). *N Engl J Med*. 2020;383:813-824. PubMed [32846060](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32846060/)

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理 | 謝慕揚 MD, PhD, FESC

本投影片由 *Claude Code* 協助整理，內容已核對原文